Optimizing the Nutrition Care Pathway

Dim3 Products Financial Outcome

Dim3
See detail from global



Individualized Support Across the Continuum

Dim3 is establishing a data continuum between hospital, nursing homes and homecare to improve patient outcomes

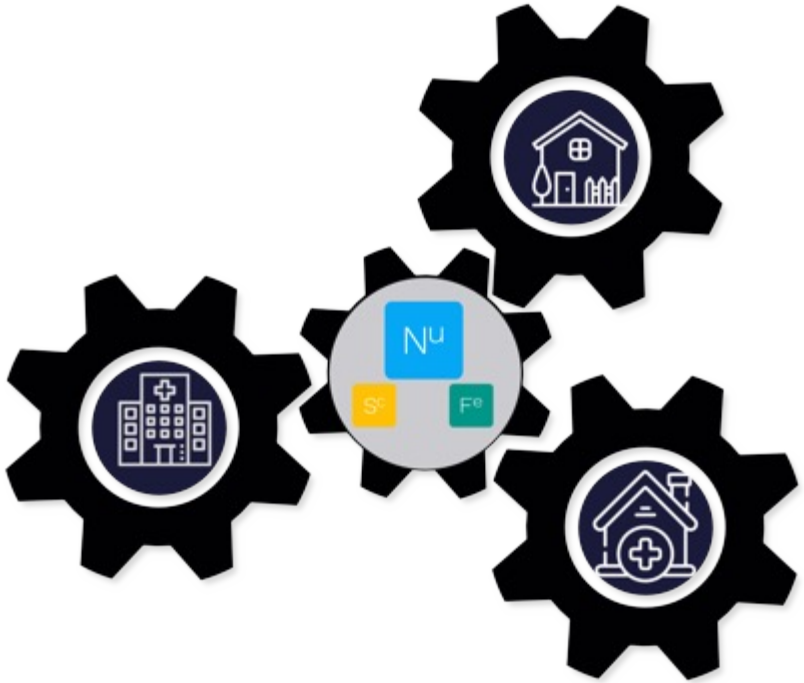


Individualized Support Across the Continuum

By increasing compliance with better prescription and follow-up,

Dim3 solution has a direct impact on specialized food products sales from hospital to home

Enteral / Food Complements / Adapted food **Oncology** – Sarcopenia - Pediatric …

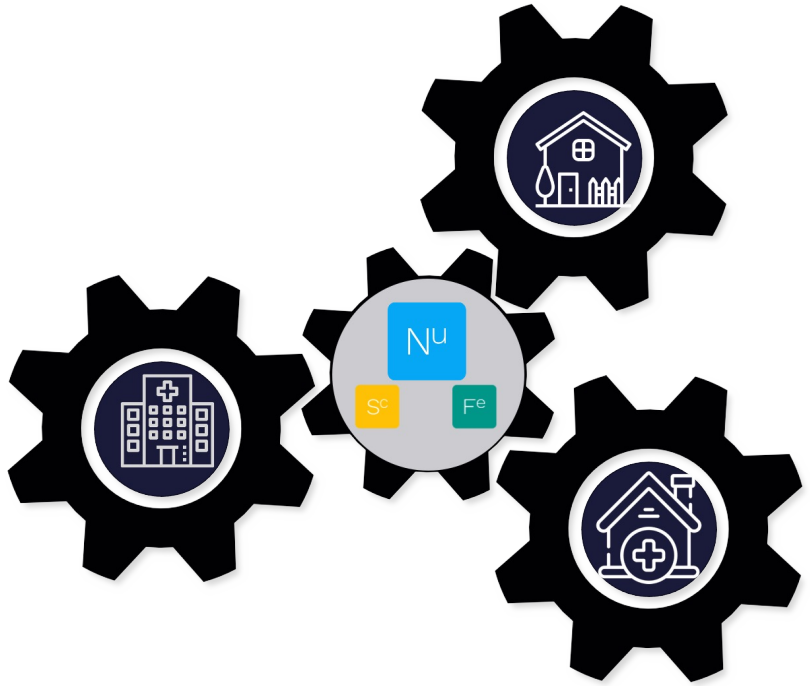


Individualized Support Across the Continuum

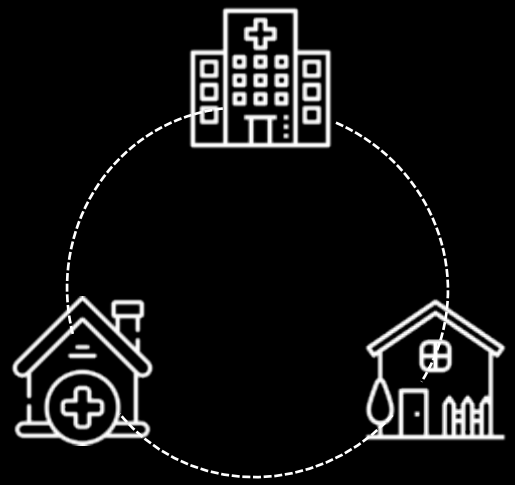
By increasing compliance with better prescription and follow-up,

Dim3 solution has a direct impact on Hospital reimbursement systems in several countries

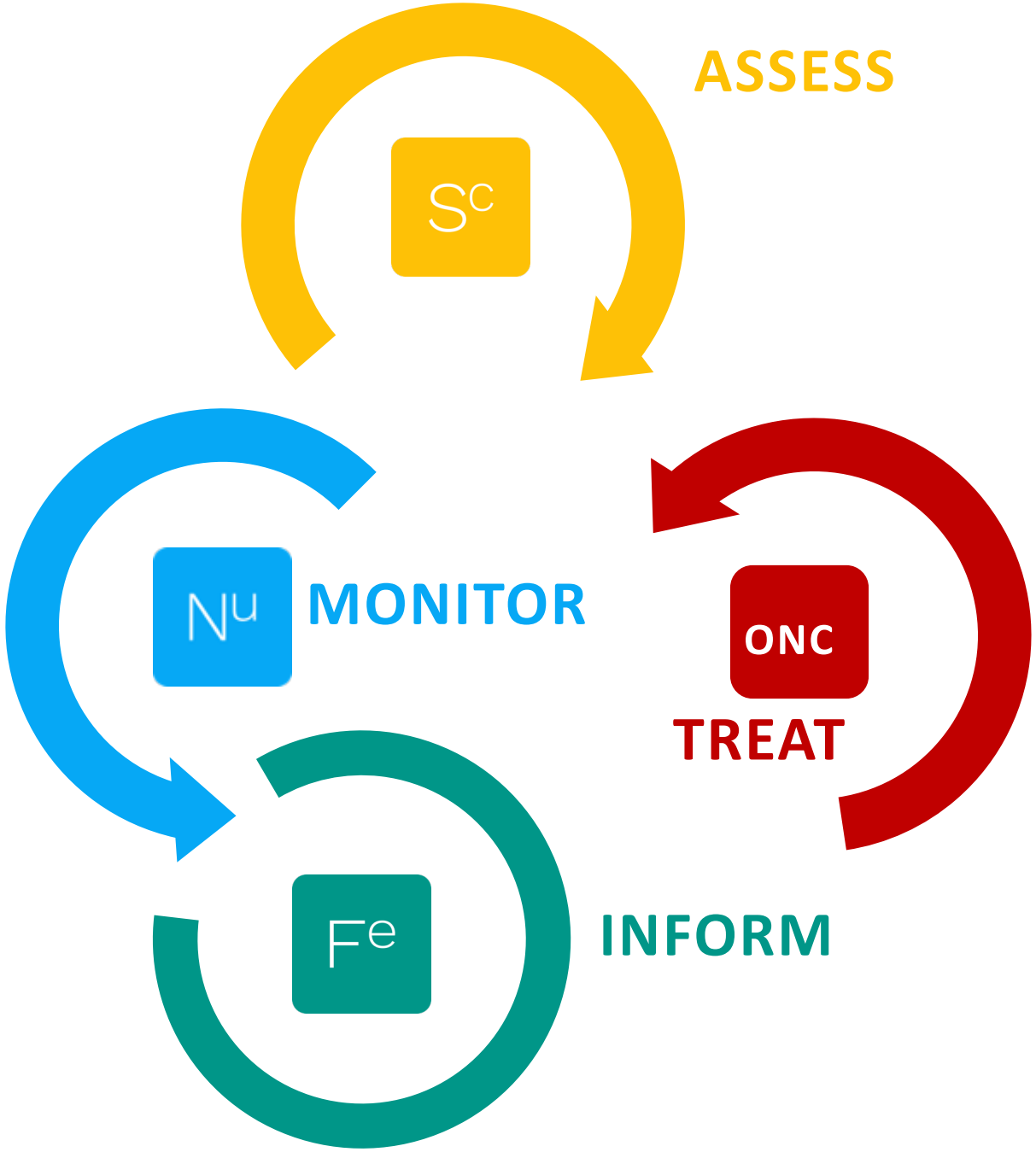
By a documented monitoring of clinical nutrition , ICD10 / Reimbursment files increase reimbursement when malnutrition is present and fighted.



The First 360° Clinical Nutrition Management System

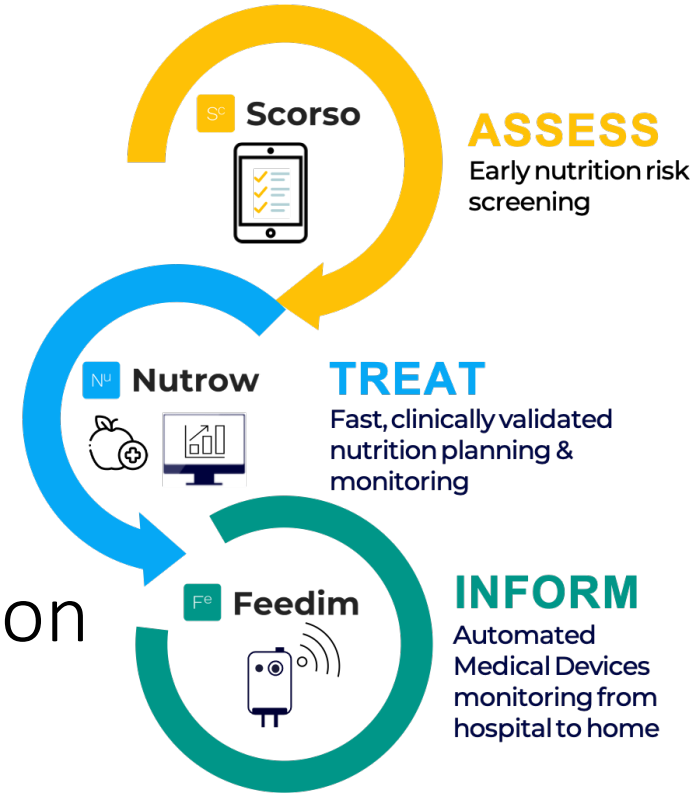


FROM HOSPITAL→ HOME



Dim3
See detail from global

FAITS



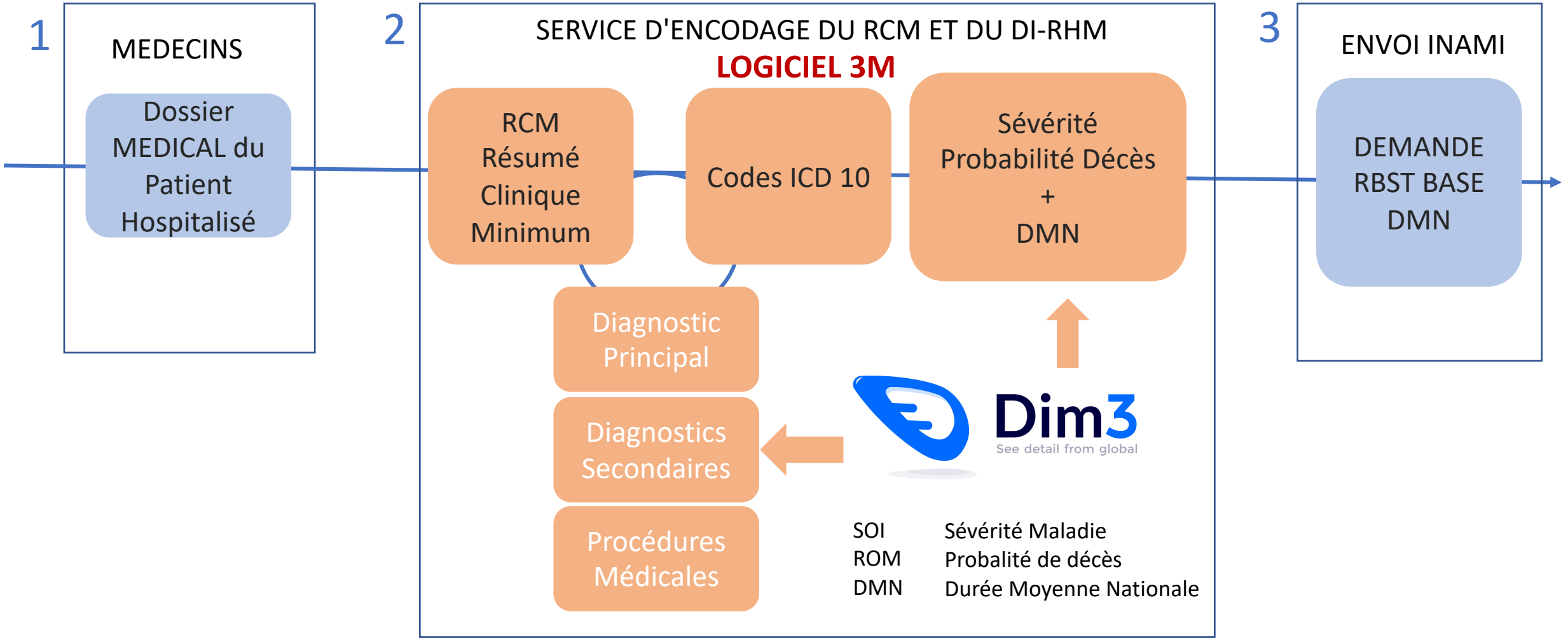
30-50% des patients hospitalisés à risque Denutrition

33% des patients hospitalisés sont Dénutris

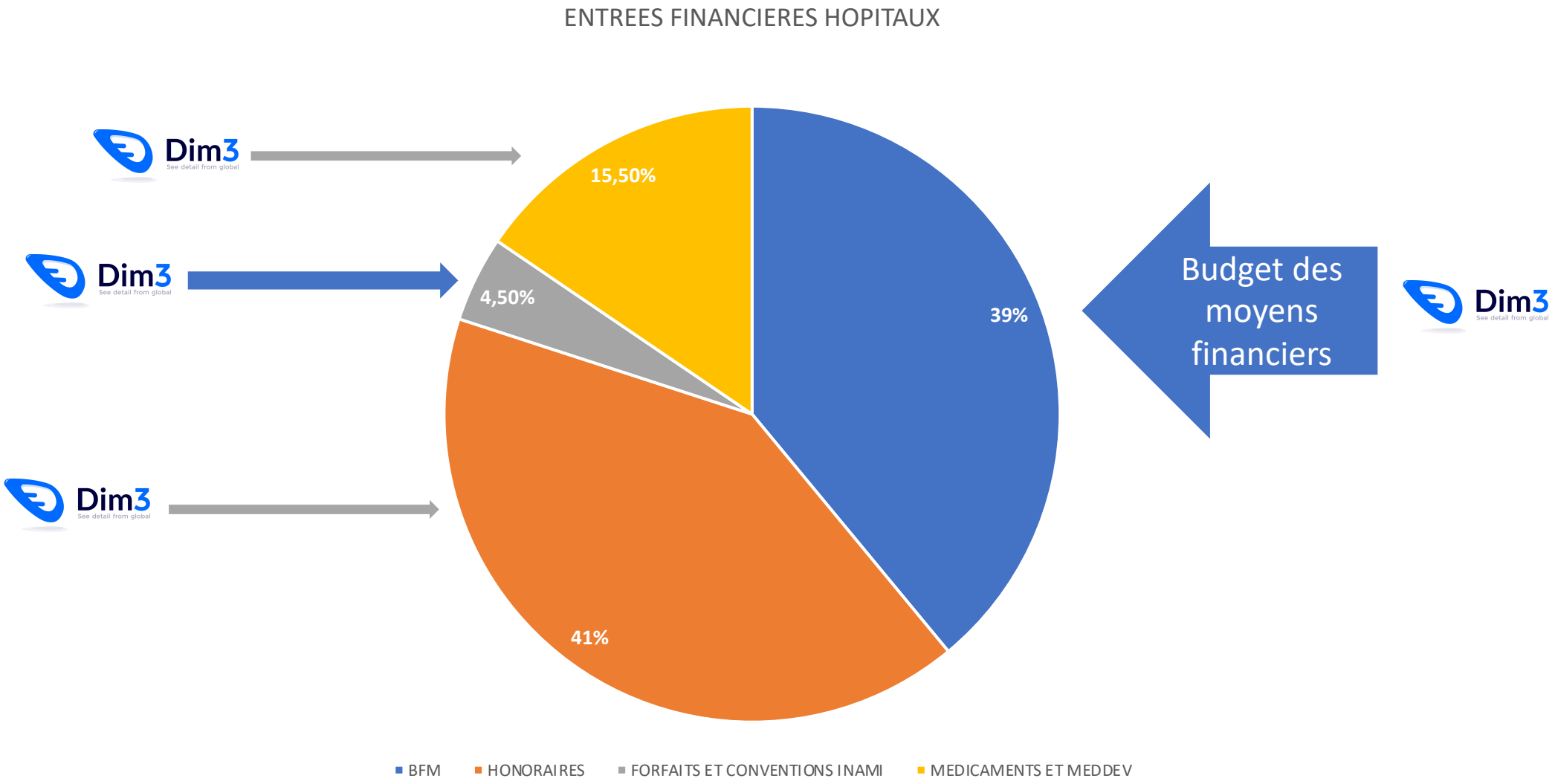
35% des patients sont dénutris à la sortie

30% des patients à risque sont dénutris à la sortie

Financement Public des Hopitaux
Budget des Moyens Financiers (BMF) = 39% entrées Financieres



Financement des Hopitaux



Impact de la plateforme DIM3 :
Mise en evidence et codification malnutrition ICD10
Integration automatisable dans procedure RHM

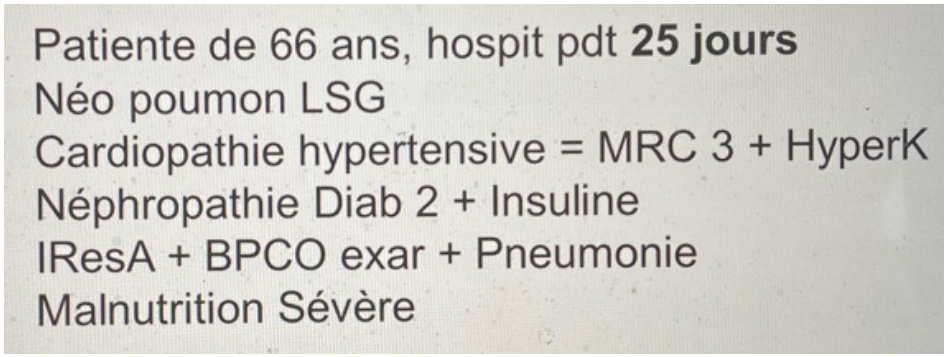
ICD 10 Malnutrition/obésité et Points Séverité ajoutés

+ OBESITE = 1 à 2 points

E40 / E41 / E42 = Kwashuirkor/Marasme …	4 points
E43 = Malnutrition Sévere	4 Points
E440 = Malnutrition Modérée	3 Points
E441 = Malnutrition légère	2 Points
E46 = Malnutrition unspecified	3 Points

ROI de la plateforme DIM3 : DATA 1 Erasme

Source Mme Farine chef de service dietetique / congrès de diététique thérapeutique Erasme du 27/05



Perte DMN = 23 jours si diagnostic primaire RCM
Perte DMN = 21 jours si diagnostic primaire + secondaires RCM
Perte DMN = 15 jours Affinage des Sévérités et Mortalités
Perte DMN = 0 jours en incluant Malnutrition sévère

Analyse RCM ERASME (Référence Nationale en Nutrition Clinique)

51 patients au hasard

16 Dénutris = 31%. / Denutrition modérée 4 / Denutrition severe 12

Réanalyse RCM

= 10 % des hospitalizations gagnent 1 point de sévérité si on inclut la malnutrition en mode digital (Dim3)

2 patients passent de 2 à 3 de sévérité / 4% des hospitalisation

3 patients passent de 3 à 4 de sévérité / 6% des hospitalisations

ROI de la plateforme DIM3 : Data 2

Analyse RCM CHC: *Source Francoise Martin Coordinatrice nutritionnelle CHC*
sur 6O patients codés 43 journées récupérées = **0,72 jours/Hospi**

Analyse CHU Namur : *Virginie Vanesse, Chef de service Alimentation Diététique*
sur 47 patients codés 20 dossiers augmentent la sévérité = **43% des dossiers**
L'ajout de données : laboratoires/malnutrition impacte le codage de 109 jours sur 47 dossiers = **2,3 jours/Hospi**

En Moyenne une journée = 600€ de remboursement (Source Inami)

ROI de la plateforme DIM3 :

Dans un hospital majeur, 10% des admissions peuvent avoir une augmentation de sévérité de 1 point.

- Nombre Admissions de votre hopital = 30.000
- Bilan DMN ou Total Points de Sévérité de votre RMN
- 3.000 points de sévérité en plus dans votre RMN
- **1 jours gagnés par point (prévision basse) = 1.800.000 d'augmentation de remboursement**



Dim3 vous propose de valider ce chiffre par une collaboration avec votre département nutrition et RHM

Infos Slides

Dim3 Products
Financial
Outcome

Dim3
See detail from global

